Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gelsomini
Dipartimento di Diagnostica per Immagini
UOC Radiodiagnostica - Settore RM Body
Direttore: Prof. Corrado Pappalardo
Referente RM in pazienti portatori di dispositivi: Dott. Alfio Torrisi

Viale Vincenzo Giuffrida 211
95124 Catania
Prenotazioni RM: 095 3782140
Fax 095 3782199
rm.body@policlinicogelsomini.example.it

REFERTO DI RISONANZA MAGNETICA

RM multiparametrica della prostata (T2, DWI, DCE) in paziente portatore di pacemaker MR-conditional

DATI ANAGRAFICI

Cognome:	**LO PRESTI**
Nome:	**SALVATORE**
Nato a:	**Catania il 03/02/1951 (75 anni)**
Domicilio:	**Via Cristoforo Colombo 17, 95030 Gravina di Catania**
Telefono:	**095 418327 / 347 2260918**
Esenzione:	**C03 - invalido civile 75%**

N. accesso:	RM-2026-0071548
Prenotazione CUP:	CT260918-04417
Impegnativa NRE:	1900A1385204976
Data prescrizione:	18.09.2026
Data esame:	8 ottobre 2026, ore 15:10
Data referto:	09/10/2026
Prescrittore:	Dott. Filippo Messina, UOC Urologia

Accession: RM-2026-0071548

Codice fiscale L P R S V T 5 1 B 0 3 C 3 5 1 F

Tessera TEAM 8 0 3 8 0 0 8 0 6 4 3 1 3 4 4 9 7 4 3 6

QUESITO CLINICO

Incremento progressivo del PSA (9,8 ng/mL il 10/09/2026; 6,1 ng/mL a marzo 2024) in paziente con precedente biopsia prostatica transrettale sistematica del 05.06.24 (12 prelievi), con riscontro di adenocarcinoma acinare Gleason 3+3 in un solo prelievo, in sorveglianza attiva. Esplorazione rettale: nodulo duro al lobo sinistro. Si richiede RM multiparametrica per ristadiazione e guida a biopsia mirata con tecnica di fusione.

Anamnesi rilevante: blocco atrioventricolare di III grado trattato con impianto di pacemaker bicamerale il 14/05/2023 presso l'Ospedale San Marziano di Acireale; fibrillazione atriale parossistica in terapia con apixaban 5 mg x 2; epatite C cronica eradicata nel 2019 con antivirali ad azione diretta; disturbo depressivo maggiore ricorrente in trattamento con sertralina 100 mg, seguito dal Centro di Salute Mentale di Gravina. Ipoacusia bilaterale con protesi acustiche (rimosse prima dell'ingresso in sala). Peso 84 kg, altezza 172 cm.

> *ALLERGIE: lattice (sala allestita in modalità latex-safe) e reazione lieve a gadobutrolo (prurito ed eritema al tronco, RM del 21 marzo 2024). Utilizzato mezzo di contrasto macrociclico a diversa molecola dopo premedicazione con metilprednisolone 32 mg per os a 12 e 2 ore e clorfenamina 10 mg ev, somministrata dall'inf. Venera Grasso.*

SICUREZZA RM - DISPOSITIVO CARDIACO IMPIANTATO

Dato del dispositivo	Valore
Generatore	Pacemaker bicamerale Cadenza DR MRI
N. di serie generatore	CDR-M 704512S
Elettrocatetere atriale (n. serie)	VSL-52A 3318820
Elettrocatetere ventricolare (n. serie)	VSL-58V 3320417
Tesserino portatore	VS-IT-0098731
Condizionalità	sistema completo MR-conditional 1,5 T, full body

Parametro	Pre-RM	Post-RM
Modalità programmata	DDD 60 bpm	DDD 60 bpm
Modalità in RM	DOO asincrona	-
Soglia V (V a 0,4 ms)	0,75	0,80
Impedenza V (Ohm)	610	598
Onda R (mV)	11,2	10,9
Batteria (anni stimati)	8,5	8,4

Riprogrammazione in modalità sicura RM e riattivazione eseguite dal cardiologo Dott. Giuseppe Scuderi (UOC Cardiologia con UTIC - Ambulatorio Pacemaker) con il supporto dello specialista di prodotto sig. Marco Nicotra (Vitalsync Italia S.r.l.). Monitoraggio continuo ECG e SpO2 per tutta la durata dell'esame; defibrillatore e carrello di emergenza in zona controllata. SAR limitato a 2 W/kg (modalità Normal Operating).

Checklist di sicurezza RM (compilata dal TSRM Concetta Caruso)

☒ Questionario di sicurezza firmato
☒ Dispositivo verificato su elenco produttore
☒ Elettrocateteri abbandonati assenti

Il referto contiene dati personali relativi alla salute: chi lo riceve per errore è tenuto a distruggerlo e a darne avviso al mittente (Reg. UE 2016/679).

☒ Cardiologo presente in sala comandi ☒ Protesi acustiche rimosse ☐ Sedazione necessaria
☐ eGFR < 30 mL/min ☐ Clips vascolari / schegge metalliche ☒ Consenso informato acquisito

TECNICA DI ESAME

Sequenza	Piano	Spessore	Note
T2 TSE ad alta risoluzione	assiale, sagittale, coronale	3 mm	bobina phased-array pelvica, senza bobina endorettale
DWI (b 0-50-800-1400)	assiale	3 mm	mappa ADC calcolata; b 1400 acquisito direttamente
T1 3D GRE dinamica (DCE)	assiale	3 mm	risoluzione temporale 7 s; acido gadoterico 0,1 mmol/kg (17 mL) a 2,5 mL/s
T1 TSE	assiale ampio FOV	5 mm	studio linfonodale e scheletrico del bacino

Esame eseguito su apparecchiatura da 1,5 T (vincolo del dispositivo impiantato), previa somministrazione di butilscopolamina 20 mg im per ridurre gli artefatti da peristalsi. Acquisizione a cura dei TSRM Concetta Caruso e Orazio Maugeri. Qualità di esame adeguata (PI-QUAL 4); lieve artefatto da suscettibilità magnetica della regione pettorale sinistra, ininfluente sulla valutazione pelvica.

Confronto con RM prostata del 21/03/2024 (acc. RM-2024-0118220), eseguita presso questa UOC su apparecchiatura da 3 T, refertata dal Dott. A. Torrisi (lesione PI-RADS 3 al lobo sinistro).

DESCRIZIONE

Prostata di dimensioni aumentate: diametri 52 x 41 x 45 mm, volume stimato (ellissoide) 47,6 mL; densità del PSA 0,21 ng/mL². Iperplasia della zona di transizione con noduli di aspetto adenomatoso, prevalentemente stromali, con capsula chirurgica continua.

Nella **zona periferica posterolaterale sinistra**, a livello medio-ghiandolare e basale, si apprezza lesione focale ipointensa in T2 a margini sfumati di 16 x 12 mm (precedente 9 x 7 mm), con marcata restrizione della diffusione (ADC medio 640 µm²/s) e impregnazione precoce e focale nello studio dinamico. La lesione ha contatto capsulare per circa 11,5 mm con lieve bulging del profilo, senza evidente infiltrazione del grasso periprostatico; angolo retto-prostatico conservato; fascia di Denonvilliers integra. Fasci neurovascolari simmetrici. Plesso venoso di Santorini nella norma.

Vescicole seminali simmetriche, di normale segnale. Non adenopatie iliache o otturatorie di dimensioni significative (linfonodo otturatorio sinistro di 6,4 mm in asse corto, morfologia ovalare con ilo adiposo conservato). Non alterazioni di segnale focali del bacino osseo e dei corpi vertebrali lombari inferiori inclusi nel campo di vista. Diverticoli del sigma non complicati.

Mappa delle lesioni secondo PI-RADS v2.1 (settori a 41 regioni; doppia lettura Dott.ssa S. Spampinato / Dott. A. Torrisi)

Lesione	Settore	Dimensioni	T2W	DWI	DCE	PI-RADS	Variazione vs 2024
1 (indice)	PZpl sx medio-base	16 x 12 mm	4	5	+	**PI-RADS 5**	aumento dimensionale, upgrade da PI-RADS 3
2	TZa dx apice	8,3 mm	3	2	-	PI-RADS 2	invariata, aspetto di nodulo adenomatoso atipico

CONCLUSIONI

Lesione della zona periferica posterolaterale sinistra PI-RADS 5, in significativo aumento rispetto all'esame del 2024, altamente sospetta per carcinoma prostatico clinicamente significativo, con contatto capsulare esteso ma senza segni certi di estensione extraprostatica (EPE grado 1). Non adenopatie né lesioni ossee sospette nel campo di vista. Si consiglia biopsia mirata con tecnica di fusione RM/ecografia sulla lesione 1, associata a campionamento sistematico; immagini e contorni della lesione esportati sul sistema di fusione dell'Ambulatorio di Urologia Diagnostica.

Funzionamento del pacemaker regolare al termine dell'esame, con parametri sovrapponibili ai valori basali; dispositivo riprogrammato in DDD alle ore 16:02. Il paziente è stato riaffidato al figlio, sig. Sebastiano Lo Presti, che lo ha accompagnato. Il sig. Lo Presti riprenderà apixaban la sera stessa, secondo le indicazioni già fornite dal Dott. Messina in vista della biopsia.

Il Medico Radiologo
Dott.ssa Stella Spampinato
Seconda lettura: Dott. Alfio Torrisi

POLICLINICO GELSOMINI
RADIODIAGNOSTICA
Dott.ssa STELLA SPAMPINATO
OMCeO CT n. 14872

Catania, 09/10/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1 - SCHEDA DI MONITORAGGIO CARDIOLOGICO IN CORSO DI RM

Paziente:	Salvatore Lo Presti	Nato il:	03.02.1951	Cartella amb.:	CARD-PM-2023-1187
Cardiologo:	Dott. G. Scuderi	Specialista ditta:	M. Nicotra	Infermiere:	V. Grasso

Ora	Fase	FC (bpm)	PA (mmHg)	SpO2	Ritmo / note
14:52	Ingresso, riprogrammazione DOO	80	146/82	97%	ritmo stimolato, cattura efficace
15:10	Inizio acquisizione	80	141/80	98%	nessuna aritmia
15:31	Somministrazione mdc	80	138/79	98%	nessuna reazione; riferito lieve calore
15:48	Fine acquisizione	80	135/78	98%	-
16:02	Riprogrammazione DDD	64	132/76	97%	ritmo sinusale con stimolazione ventricolare sincrona

Osservazione post-contrasto di 30 minuti senza eventi avversi. Il paziente è stato informato, in presenza del figlio S. Lo Presti, di presentarsi in Pronto Soccorso in caso di sincope, cardiopalmo o reazione cutanea tardiva. La moglie, sig.ra Agata Fichera, è stata indicata come ulteriore recapito al numero 095 418327.

Il Cardiologo

Dott. Giuseppe Scuderi
Controllo pacemaker programmato tra 3 mesi presso l'Ambulatorio Pacemaker

A.O.U. POLICLINICO GELSOMINI
UOC CARDIOLOGIA CON UTIC
Dott. Giuseppe Scuderi
Ord. Medici CT n. 11906

Catania, 08/10/2026

ALLEGATO 2 - CONSENSO INFORMATO ALL'ESAME RM IN PORTATORE DI DISPOSITIVO

Io sottoscritto Salvatore Lo Presti, nato a Catania il 3 febbraio 1951, dichiaro di essere stato informato dal Dott. Alfio Torrisi sui rischi specifici dell'esame RM in presenza di pacemaker, sulla necessità della riprogrammazione del dispositivo e sull'uso del mezzo di contrasto in presenza di pregressa reazione, e di acconsentire all'esecuzione dell'esame. Data l'ipoacusia, il colloquio è stato condotto anche in forma scritta, alla presenza del figlio Sebastiano Lo Presti (tel. 349 7703512).

ACCETTAZIONE RM
08 OTT 2026
TSRM O. MAUGERI

Referto di LO PRESTI S. su FSE: https://fse.policlinicogelsomini.example.it/referti/RD/26/0093317

Firma del paziente

Salvatore Lo Presti
Presente: Sebastiano Lo Presti (figlio)

Catania, 08/10/2026

(1) PI-RADS v2.1 (2019): punteggio dominante DWI per la zona periferica, T2W per la zona di transizione. Gleason secondo ISUP 2014 (Gleason 3+3 = Grade Group 1).
(2) Condizioni d'uso RM del sistema Cadenza DR MRI secondo il manuale tecnico del produttore (rev. 2022): 1,5 T, gradiente spaziale massimo 30 T/m.
(3) Medico di medicina generale: Dott.ssa Carmela Leonardi, Via Etnea 642, Gravina di Catania - copia inviata via FSE il 09.10.2026.